أنواع الإسعافات الأولية



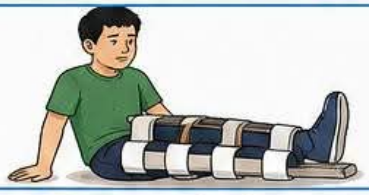
إسعافات الجروح

تنظيف الجرح، إيقاف النزيف، وتغطيته بضماد نظيف.



إسعافات الحروق

تبريد مكان الحرق بالماء البارد وعدم وضع مواد ضارة عليه.



إسعافات الكسور والإلتواءات

تثبيت العضو المصاب وعدم تحريكه حتى وصول المساعدة.



إسعافات الاختناق

مساعدة المصاب على التنفس وإزالة سبب الاختناق بسرعة.



إسعافات الإغماء

وضع المصاب في مكان جيد التهوية ورفع رجليه قليلاً.



إسعافات النزيف

الضغط على مكان النزيف لإيقاف فقدان الدم.



الإسعاف القلبي الرئوي

يُستعمل عند توقف التنفس أو القلب لإنقاذ حياة المصاب.



إسعافات التسمم

إبعاد المصاب عن المادة السامة وطلب الإسعاف فوراً.



إسعافات ضربة الشمس

نقل المصاب إلى مكان بارد وتقديم الماء له تدريجيًا.



إسعافات لدغات الحشرات أو العضات

تنظيف مكان الإصابة وتهدئة المصاب ومراقبة الأعراض.

ملتقى اساتذة التربية البدنية و الرياضية

أمثلة عن الإسعافات الأولية مع الشرح

1 إسعاف النزيف



عند تعرض شخص لجرح ينزف:

- نضغط على مكان الجرح باستعمال قطعة قماش نظيفة أو شاش.
- نرفع العضو المصاب إن أمكن لتقليل تدفق الدم.
- إذا استمر النزيف نتصل بالإسعاف.

الهدف: إيقاف فقدان الدم وحماية المصاب من الخطر.

2 إسعاف الحروق



عند حدوث حرق بالماء الساخن أو النار:

- نضع مكان الحرق تحت ماء بارد لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
- لا نضع معجون الأسنان أو الزيت أو القهوة على الحرق.
- نغطي الحرق بقطعة نظيفة.



الهدف: تخفيف الألم ومنع تلف الجلد.

3 إسعاف الإغماء



إذا فقد شخص وعيه:

- نضعه على ظهره ونرفع قدميه قليلاً.
- نفتح له مجال التنفس والهواء.
- لا نسكب الماء على وجهه بعنف.
- إذا لم يستيقظ بسرعة نظلب الإسعاف.



الهدف: إعادة وصول الدم والأكسجين إلى الدماغ.

4 إسعاف الكسور



عند الاشتباه في كسر:

- لا نحرك العضو المصاب كثيرًا.
- نثبت الكسر بقطعة خشب أو قماش إن أمكن.
- ننقل المصاب بحذر إلى الطبيب.

الهدف: منع زيادة الإصابة أو تحرك العظم.

5 إسعاف الاختناق



شجعه على السعال أولاً



مناورة هايمليك



اتصل بالإسعاف



إذا كان الشخص لا يستطيع التنفس بسبب جسم عالق:

- نشجعه على السعال أولاً.
- إذا لم يستطع التنفس نقوم بالضغطات البطنية (مناورة هايمليك).
- نتصل بالإسعاف بسرعة إذا استمرت الحالة.

الهدف: فتح مجرى التنفس وإنقاذ المصاب.

6 إسعاف الالتواء أو الكدمات



عند التواء القدم أو ظهور كدمة:

- نضع الثلج ملفوفا في قماش لمدة 15 دقيقة.
- نريع العضو المصاب.
- نرفع القدم أو اليد لتقليل التورم.



الهدف: تخفيف الألم والانتفاخ.

7 إسعاف الصعقة الكهربائية



عند التعرض للكهرباء:

- نقطع التيار الكهربائي أولاً.
- لا نلمس المصاب مباشرة قبل فصل الكهرباء.
- نفحص التنفس والوعي ثم نظلب الإسعاف.

الهدف: حماية المنقذ والمصاب من الخطر.

★ قاعدة مهمة

المسعف الجيد

لا يسبب ضررًا إضافيا للمصاب.







الاسعافات الاولية
لإصابات التربية البدنية



التصرف السريع والصحيح يقلل الألم ويمنع تفاقم الإصابة

خطوات عامة في جميع الإصابات

1 أوقف النشاط فوراً

أوقف المصاب عن النشاط والحركة.



2 اطمئن على المصاب

تأكد من وعيه وتنفسه وعدم وجود إصابات خطيرة.



3 قيم الإصابة

حدد نوع الإصابة وشدتها.



4 قدم الإسعاف المناسب

طبق الإسعاف الأولي المناسب لنوع الإصابة.



5 اطلب المساعدة الطبية

إذا كانت الإصابة شديدة أو لا تتحسن.



أشهر الإصابات وكيفية إسعافها

1- شد أو تمزق عضلي



- **R** الراحة (Rest)
- **I** الثلج (Ice)
- **C** الضغط (Compression)
- **E** الرفع (Elevation)

- أوقف النشاط فوراً.
- ضع كمادات ثلج لمدة 15-20-دقيقة كل --3-ساعات.
- اربط المكان برباط ضاغط غير مشدود جداً.
- أرفع الطرف المصاب فوق مستوى القلب.
- راجع الطبيب إذا استمر الألم أو التورم.

2- التواء المفصل (التمزق الرياطي)



- **R** الراحة (Rest)
- **I** الثلج (Ice)
- **C** الضغط (Compression)
- **E** الرفع (Elevation)

- لا تحاول تحريك المفصل المصاب.
- ضع ثلجاً على المنطقة لمدة 15-20-دقيقة.
- أربط بمرباط ضاغط.
- أرفع الطرف المصاب.
- راجع الطبيب إذا كان التورم شديداً أو لا تستطيع المشي.

3- الكدمات



- ضع كمادة ثلج مباشرة على مكان الكدمة لمدة 15-20-دقيقة.
- كرر ذلك خلال أول 24-48-ساعة.
- يمكن استخدام رباط ضاغط خفيف إذا لزم الأمر.
- تجنب التدليك في الساعات الأولى.

4- نزيف الأنف



- اجلس واملْ ـرأسك قليلاً إلى الأمام.
- اضغط على الأنف من الأعلى لمدة 10 دقائق.
- تنفس من الفم وضع كمادة باردة على الأنف.
- لا ترفع ـرأسك للخلف.
- إذا لم يتوقف النزيف راجع الطبيب.

5- الجروح والخدوش



- اغسل الجرح بالماء النظيف والصابون.
- أزل الأوساخ بلطف.
- ضع مطهراً مناسباً.
- غطه الجرح بشاش معقم أو لاصق طبي.
- غير الضمادة يومياً.

6- الإجهاد الحراري



- انقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد.
- أخفِ ملابسه الزائدة.
- برّد جسمه بكمادات باردة أو مروحة.
- أعطه ماء أو محلول أملاح إذا كان واعياً.
- إذا فقد الوعي أو استمر الغثيان: اطلب المساعدة الطبية فوراً.

أشياء يجب تجنبها



لا تترك المصاب وحده حتى تتحسن حالته أو يصل المساعدة.



لا تضع مراهم أو زيوت أو مواد شعبية على الإصابة.



لا تحرك أو تعيد المفصل أو العظم المصاب.



لا تعطي المصاب أي دواء بدون استشارة طبية.

دليل سريع لشدة الإصابة

بسيطة	ألم خفيف – تورم بسيط – لا يؤثر على الحركة (تعالج في الموقع)
متوسطة	ألم وتورم متوسط – محدودية حركة (تحتاج متابعة ورعاية)
شديدة	ألم شديد – تورم كبير – تشوه – فقدان وظيفة (تحتاج علاج طبي عاجل)

متى تذهب إلى المستشفى فوراً؟



- إذا كان هناك كسر أو تشوه واضح في العظام.
- إذا كان هناك فقدان للوعي أو تشنجات.
- إذا كان النزيف لا يتوقف.
- إذا كان هناك صعوبة في التنفس.
- إذا استمر الألم الشديد أو التورم.
- إذا كانت الإصابة في الرأس، الرقبة، أو العمود الفقري.



ملتقى اساتذة التربية البدنية و الرياضية





الرعاف (نزيف الأنف)

الأسباب والإسعاف الأولي



أسباب الرعاف

الرعاف يحدث غالبًا بسبب تمزق شعيرات دموية داخل الأنف، ومن أهم الأسباب:

1 الجفاف



الهواء الجاف أو الحرارة يسبب تشقق داخل الأنف

2 الضربات أو السقوط



خاصة أثناء اللعب أو النشاط الرياضي

3 حكّ الأنف أو إدخال جسم غريب



شائع عند الأطفال

4 التعب أو المجهود البدني



ارتفاع الضغط داخل الأوعية الدموية

5 أمراض أو حالات صحية



- ارتفاع ضغط الدم
- فقر الدم
- نزلات البرد أو الحساسية

طريقة الإسعاف الأولي للرعاف



1 اجلس المصاب وميل رأسه قليلاً للأمام



ما ترجعش الرأس للخلف (باش ما يبلعش الدم)

2 اضغط على الأنف



اضغط على الجزء اللين من الأنف (تحت العظم) لمدة 10 دقائق بدون توقف

3 خليه يتنفس من الفم



4 وضع كمادات باردة



على الأنف أو الجبهة تساعد على تقليل النزيف

نصيحة في حصة التربية البدنية



راقب التلاميذ خاصة في الجو الحار



تأكد من شرب الماء



تدخل بسرعة وبهدوء عند حدوث الرعاف

متى نحتاج طبيب؟



إذا استمر النزيف أكثر من 15 دقيقة



إذا تكرر بشكل دائم



إذا كان بعد ضربة قوية



أو مع دوخة شديدة

أخطاء لازم نتفادوها



❌ إرجاع الرأس للخلف



❌ إدخال مناديل عميق داخل الأنف



❌ التوقف عن الضغط كل شوية



ملتقى اساتذة التربية البدنية و الرياضية





اسباب الغثيان
اثناء حصة التربية البدنية



الغثيان أثناء حصة التربية البدنية عند التلاميذ (أو حتى الكبار) ظاهرة شائعة، وغالباً تكون نتيجة أسباب بسيطة لكنها نحتاج انتباه.

1 الأكل قبل الحصة مباشرة



إذا التلميذ أكل وجبة ثقيلة وقريبة من وقت النشاط:

- الدم يتوجة للهضم بدل العضلات
- تصير اضطرابات في المعدة ← غثيان

✓ الحل:

يكون الأكل قبل الحصة بـ 2 – 3 ساعات، أو وجبة خفيفة فقط

2 الجهد البدني المفاجئ



الانطلاق مباشرة في الجري أو التمارين بدون إحماء:

- الجسم ما يكوبش مهيأ
- يؤدي للدوخة والغثيان

✓ الحل:

إحماء تدريجي ومنظم

3 الجفاف (نقص الماء)



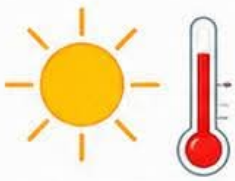
قلة شرب الماء:

- تسبب تعب سريع
- صداع وغثيان

✓ الحل:

شرب الماء قبل وأثناء وبعد الحصة

4 الحرارة المرتفعة



اللعب تحت الشمس أو في جو حار:

- ارتفاع حرارة الجسم
- ممكن يؤدي لغثيان أو حتى إغماء

✓ الحل:

اختيار وقت مناسب + فترات راحة

5 التعب أو قلة النوم



التلميذ يكون مرهق:

- الجسم ما يتحملش الجهد
- تظهر أعراض مثل الغثيان

6 القلق أو الخوف



بعض التلاميذ يقلقوا من النشاط أو المنافسة:

- تأثير نفسي يتحول لأعراض جسدية (غثيان)

7 مشاكل صحية



مثل:

- انخفاض السكر
- فقر الدم
- أمراض معدية

✓ هنا لازم متابعة طبية إذا تكررت الحالة

نصيحة كأستاذ تربية بدنية



راقب التلاميذ بانتباه



خفف شدة التمرين تدريجيًا



اسأل التلاميذ قبل الحصة إذا حاسين بتعب

متى نقلق؟

إذا كان الغثيان:

- متـــكرر بزاف
- مصحوب بدوخة قوية أو إغماء
- أو قيء مستمر

هنا لازم تدخل طبي



ملتقى اساتذة التربية البدنية و الرياضية



الدوخة أو فقدان الوعي والإسعاف الأولي

ما هي الدوخة؟



الدوخة هي شعور بعدم التوازن أو دوران المحيط، وقد تسبق فقدان الوعي.

ما هو فقدان الوعي؟



هو فقدان مؤقت للإدراك والاستجابة للمؤثرات الخارجية نتيجة نقص تدفق الدم أو الأكسجين إلى الدماغ.

الأعراض



دوار وعدم توازن



تعرق بارد



شحوب الوجه



فقدان الوعي في بعض الحالات



ضعف عام



تشوش الرؤية

الأسباب الشائعة



التعرض للحرارة المرتفعة



الجفاف ونقص السوائل



الجوع أو انخفاض سكر الدم



الإرهاق الشديد



بعض الأمراض أو الإصابات



انخفاض ضغط الدم



الخوف أو الصدمة النفسية

الإسعاف الأولي

عند فقدان الوعي:

1. التأكد من سلامة المكان.



2. فحص التنفس.



3. وضع المصاب في وضعية الإفاقة الجانبية إذا كان يتنفس.



4. الاتصال بالإسعاف إذا استمر فقدان الوعي.



5. مراقبة التنفس والنبض باستمرار.



عند الشعور بالدوخة:

- إجلاس المصاب أو تمديده في مكان آمن.



- رفع القدمين قليلاً لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.



- فك الملابس الضيقة.



- تهوية المكان جيداً.



- إعطاؤه الماء إذا كان واعياً وقادراً على البلع.



الوقاية



أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم



تجنب الوقوف المفاجئ بعد الجلوس أو الاستلقاء.



شرب كمية كافية من الماء.



تناول وجبات غذائية متوازنة.

تجنب ما يلي

- عدم رش الماء على الوجه بعنف.



- عدم إعطاء الطعام أو الشراب لشخص فاقد الوعي.



- عدم تحريك المصاب إذا وُجد اشتباه بإصابة في الرأس أو الرقبة.



خلاصة: الدوخة وفقدان الوعي من الحالات الشائعة التي تتطلب تدخلاً سريعاً وهادئاً، ويُعد التأكد من التنفس ووضع المصاب في وضعية آمنة من أهم خطوات الإسعاف الأولي.

حالات بلع اللسان



من الحالات الحرجة التي تحتاج إلى التدخل السريع والحيني ، إذ يمكنك إنقاذ شخص بلع لسانه عن طريق إرجاع الرأس للخلف لفتح مجرى الهواء .

الإسعافات الأولية :

1. **حرك** المصاب وضعه على ظهره بمساعدة المحيطين به .



2. **إدفع** ذقن المصاب مع إرجاع الرأس إلى الوراء .



3. **إمسك** جبهة المصاب بيدك وإدفع على جبهته أو فكه .



4. سوف **يعود اللسان** إلى وضعه الطبيعي .



5. قم **بتغيير وضعه** مستلقيا على جانبه .



6. **لا تحرك اللسان** بيدك لأن عضلات اللسان ليست بالسهولة التي تتوقعها فقد تتسبب في إختناق الشخص المصاب .



7. حاول أن **لا تدخل يدك في اللعاب** حتى لا يطبق الشخص بأسنانه على يديك وتتمزق .



8. تذكر أن الشخص المصاب **ليس في حالة وعي** لتذكره بأن يفتح فمه .





تذكر أنه يمكنك **إنقاذ** شخص بلع لسانه إذا إتبعت هذه المراحل بكل **بدقةَ** وحافظت على **هدوء** أعصابك وتركيزك سيدي الكريم

ملتقى اساتذة التربية البدنية و الرياضية



الاختناق (انسداد مجرى التنفس)
والإسعاف الفوري



العلامات والأعراض



- صعوبة أو انعدام التنفس
- عَدم القدرة على الكلام أو السعال
- الإمساك بالرقبة (علامة الاختناق)
- ازرقاق الشفاه أو الوجه
- فقدان الوعي في الحالات الشديدة

الأسباب الشائعة للاختناق

- ابتلاع قطع طعام كبيرة دون مضغ جيد
- بلع أجسام صغيرة (خاصة عند الأطفال)
- التحدث أو الضحك أثناء الأكل
- وجود جسم غريب في الحلق

ما هو الاختناق؟

الاختناق هو حالة طارئة تحدث عندما يُسدّ مجرى الهواء (الحلق أو القصبة الهوائية)، مما يمنع دخول الهواء إلى الرئتين، وقد يؤدي إلى صعوبة التنفس أو فقدان الوعي إذا لم يتم التدخل بسرعة.

إذا كان المصاب واعيًا

1 شجِّعه على السعال بقوةٍ



2 إذا لم ينجح:

أولاً: الضربات على الظهر

(5 ضربات قوية بين لوحي الكتف)



ثانيًا: مناورةَ هيملِيك (Heimlich)

1. قف خلف المصاب
2. ضع قبضة يدكِ فوق السرة قليلاً
3. ادفعَ بقِوة إلى الداخل والأعلى
4. كرر حتى خروج الجسم الغريب



إذا فقد المصاب الوعي

1. اتصل بالإسعاف فورًا



2. ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)



3. تفقد الفم وأزل الجسم الظاهر فقط (بدون إدخال الأصابع عميقًا)



عند الأطفال

للأطفال الرضع (أقل من سنة)

1. 5 ضربات على الظهر
2. ثم 5 ضغطات على الصدر



نفس الخطوات لكن بقوة أقل



مهم جـدًا

- ابقَ هادئاً واطلب المساعدة وتصرفِ بسرعة وثقة
- التّدخل السريع ينقذُ الحياة خلال دقائق
- لا تعطي ماء أو طعام للمصاب
- لا تحاول إخراج الجسم يشكل عشوائي إذا لم يكن ظاهرًا



ملتقى اساتذة التربية البدنية و الرياضية



الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

هو إجراء إسعافي طارئ يُستخدم عند توقف القلب أو التنفس،
يهدف إلى الحفاظ على تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ وبقية أعضاء الجسم
إلى حين وصول المساعدة الطبية.

متى يتم اللجوء إلى CPR ؟

- توقف التنفس.
- توقف القلب.
- فقدان الوعي مع غياب التنفس الطبيعي.
- حالات الغرق أو الصعق الكهربائي أو الاختناق الشديد.



أهمية CPR

- ✓ الحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ.
- ✓ زيادة فرص النجاة.
- ✓ تقليل خطر تلف الدماغ ناتج عن نقص الأكسجين.
- ✓ كسب الوقت حتى وصول الإسعاف.

خطوات الإنعاش القلبي الرئوي

1 تأكد من سلامة المكان



تأكد من أن المكان آمن للمصاب والمسعف.

2 فحص الاستجابة



هز المصاب بلطف وسؤاله بصوت مرتفع: "هل أنت بخير؟"

3 طلب المساعدة



اتصل بالإسعاف (112) أو اطلب من شخص آخر الاتصال.

4 فحص التنفس



راقب حركة الصدر واستمع للتنفس لمدة لا تتجاوز 10 ثوانٍ.

5 الضغطات الصدرية



- ضع كعب اليد في منتصف الصدر.
- ضع اليد الأخرى فوقها.
- اضغط بقوة وعمق (5 - 6 سم).
- بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

6 إعطاء التنفس الاصطناعي (إذا كنت مدرباً)

النسبة المعتمدة

30 : 2

30 ضغطة صدرية
مقابل نفختين إنقاذيتين



1 إعطاء نفخة



2 إعطاء نفخة أولى

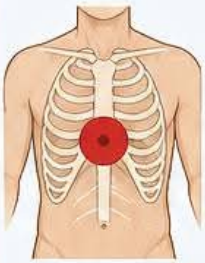


1 إعتى التنفس الهواء

أخطاء شائعة يجب تجنبها

- ✗ إيقاف الضغطات لفترات طويلة.
- ✗ الضغط في مكان خاطئ (ليس منتصف الصدر).
- ✗ ضغطات ضعيفة أو سطحية جداً.
- ✗ زيادة عدد النفخات عن المطلوب.
- ✗ عدم فتح مجرى الهواء جيداً.

عمق الضغط ومكانه



- مكان الضغط: منتصف (على عظمة القص).
- عمق الضغط: 5 - 6 سم للبالغين.
- الذراعان مستقيمان والكتفان فوق اليدين.

ملاحظات مهمة

- استمر في الإنعاش حتى وصول الإسعاف أو استعادة المصاب لتنفسه الطبيعي.
- إذا لم تكن مدرباً على التنفس الاضطناعي، يمكنك الاكتفاء بالضغطات الصدرية المستمرة بدون توقف.
- تأكد من عمق الضغط وتكراره بشكل صحيح.